

Fecha Última Actualización: 14-11-2024 17:14:30

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Roberto Eusebio Quevedo Godoy
Edad : 55a 10m 0d
Dirección : Pj Copiapo 0179 San Guillermo

Rut : 11.486.571-0
Fecha Nacto: 14/01/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1910966
Sexo : Masculino
Teléfono : 996800537

N° Epicrisis
420578

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 09/11/2024 09:41
Fecha Egreso : 14/11/2024 17:11

Días Estadía : 5

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abominal + Ictericia.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Cirugía HPB.

Ant:

THO Enero 2023.

Estenosis VB --> prótesis VB

05/11/24 ERCP. extracción de prótesis migrada con balon de manera frustra, se logra extraer prótesis con dormía, extracción de litiasis y barro biliar con dormía. Colangiografía de salida sin defectos de llenado. Reingresa 9/11 sensación febril, ictericia. Exámenes de laboratorio con patron colestasico y parametros inflamatorios levemente elevados, por lo que se realiza TC AP que evidencia leve dilatación de vía biliar intrahepática (ya visualizada en exámenes previas). Se inicia terapia antibiotica empirica con Tazonam. Se realiza ecografia abdominal 14/11 que evidencia vía biliar intrahepática normal con vía biliar extrahepática que mide 9mm. Paciente con evolucion favorable con terapia medica, con disminucion progresiva del patron colestasico y parametros inflamatorios con buena respuesta clinica. Se realiza colangioRNM (Pendiente informe) y se decide control precoz con equipo trasplantes.

Estudios:

TAC-AP C/C Leve dilatación de vía biliar intrahepática, hallazgo ya visualizado exámenes previos. Cambio calibre de la vía biliar extrahepática a nivel de conducto hepático común a nivel de la anastomosis ilio sin cambios. Leve esplenomegalia. de la anastomosis sin cambios.

Eco Megge 14/11: Hígado de densidad acústica normal, Vía biliar intrahepática normal, Vía biliar extrahepática mide 9mm

Ex lab

09/11: GB 10.150 N 78,5%; Hb 15; PCR 67,8; BiliT 7,56 BiliD 6,13; FA 190; GGT 401; GOT 31; GPT 76; CREA 1,13 BUN 24,9

10/11: INR 0.86 lact 8.5 bt 8.70 fa 177 ggt 282 got 33 creat 1.26 bun 38 pcr 38

11/11: Lact 8.8 bt 7.12(8.70) fa 163 ggt 243 (282) gpt 40 creat 1.20 bun 30 pcr 27 inr 0.91 hto 39 gb 4870 plt 135

12/11: Bt 5.97 (7.1 FA 185 GGT 246 GOT 29 GPT 35 creat 1.17 bun 26 pcr 17 k 5.05 gb 5300

13/11: Hb 13, leuco 4930, plaq 142000, ELP 137/4.65/110, PCR 11.

14/11: BD 3.88 (5), fa 196, ggt 249, got 46, gpt 43, crea 1.25, bun 18, pcr 8.8 (11.9), INR 0.92, hb 14, leuco 4.94, plaq 160000.

Tacrolimus: 5.2 (Previo 10)

Fecha Epicrisis : 14/11/2024 17:14

Página 1 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:34

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Diagnóstico de Egreso

COLANGITIS - THO 01/2023

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente con evolucion favorable con terapia medica, con disminucion progresiva del patron colestasico y parametros inflamatorios con buena respuesta clinica. Dada buena respuesta clinica se decide control precoz con equipo trasplantes.

Plan Post Alta

Regimen bajo en grasas
Reposo relativo
Micofenolato 500mg c/12 hrs VO
Tacrolimus 0.5mg c/12 hrs VO
Ciprofloxacino 750mg c/12 hrs 10 dias VO
Metronidazol 500mg c/8 hrs 10 dias VO
Omeprazol 20mg/dia por 10 dias VO
Paracetamol 500mg c/6 hrs por 7 dias VO
Control en 5- 7 dias en unidad de trasplantes con medico tratante con examenes.
Reconsultar SOS (Se explican signos de alarma).

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Pedro Osvaldo Bec Umanzor Gon
Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)